

Rebeca Rendón MSc., M.A.

Trastorno por juego: comprensión, protección familiar y plan de recuperación

Reunión de psicoeducación y organización del sistema de
apoyo familiar

OBJETIVOS

- Comprender qué es el trastorno por juego.
- Identificar cómo funciona el problema en esta paciente.
- Reconocer los factores que mantienen la conducta.
- Establecer medidas inmediatas de protección.
- Distribuir responsabilidades entre los familiares.
- Organizar el manejo de las deudas y del dinero.
- Coordinar tratamiento psicológico y psiquiátrico.
- Preparar un plan de prevención de recaídas.

¿Qué es el trastorno por juego?

el DSM-5-TR lo clasifica dentro de los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, aunque no exista una sustancia involucrada.

El trastorno por juego es un patrón persistente y recurrente de conducta de juego que produce deterioro o malestar clínicamente significativo en áreas personales, familiares, sociales, laborales y/o económicas.

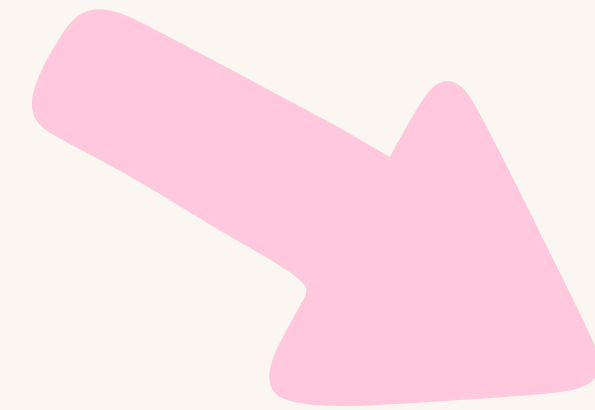
No se trata simplemente de “falta de voluntad”, irresponsabilidad o mala administración del dinero.

Existe una alteración en:

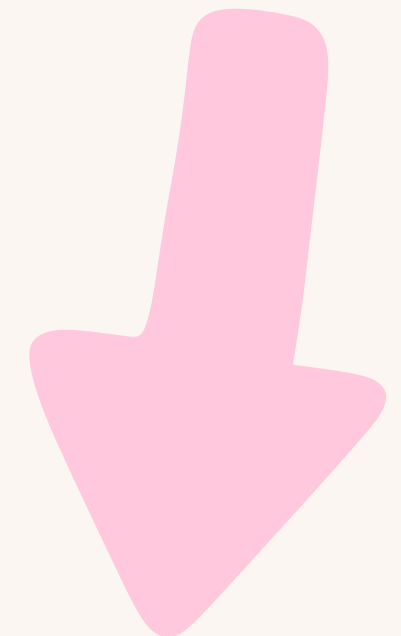
- control de impulsos;
- toma de decisiones;
- valoración del riesgo y recompensa;
- regulación emocional;
- aprendizaje por reforzamiento;
- capacidad para detener la conducta pese a sus consecuencias.



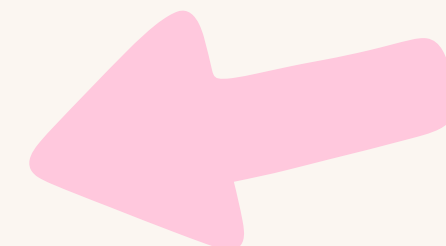
Malestar / aburrimiento /
ansiedad / necesidad de
dinero



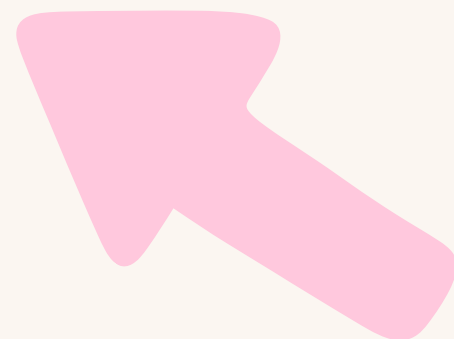
Impulso de jugar



Juego



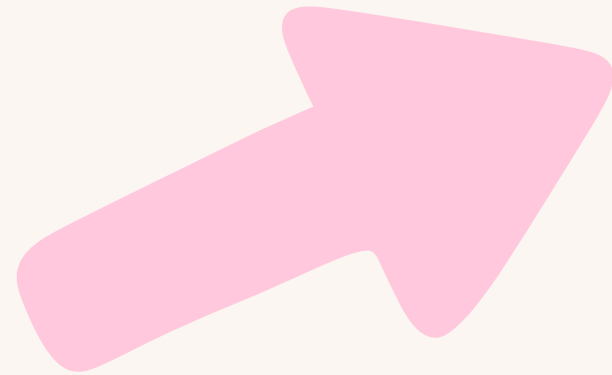
Alivio / excitación /
esperanza de ganar



Pérdida o ganancia ocasional



Necesidad de recuperar
dinero/Deudas/ Vergüenza,
ansiedad, ocultamiento



¿Cómo se convierte el juego en
un problema?

¿Por qué las pérdidas pueden aumentar el juego?

Pérdida → necesidad de recuperar → nuevo juego → nueva pérdida → deuda mayor

La paciente puede experimentar la necesidad de continuar jugando no porque quiera ganar dinero adicional, sino porque necesita recuperar el dinero que ya perdió.

¿QUÉ HACEMOS AHORA?

01

Fase 1. Protección y estabilización

Objetivo: reducir temporalmente las oportunidades de juego mientras se inicia el tratamiento.

- limitar acceso directo a grandes cantidades de dinero;
- suspender temporalmente tarjetas de crédito;
- revisar mecanismos de préstamos;
- evitar aplicaciones o plataformas de apuestas;
- bloquear sitios relacionados con juego cuando sea posible;
- evitar loterías y lugares asociados al juego;
- establecer acompañamiento durante momentos de mayor riesgo;
- centralizar temporalmente pagos importantes;
- establecer un presupuesto supervisado;
- evitar que familiares le entreguen dinero para “resolver una emergencia”.

Durante la fase inicial de mayor riesgo se recomienda aumentar significativamente la supervisión y reducir los períodos en los que tenga acceso simultáneo a dinero, dispositivos y oportunidades de juego.

Momentos de alto riesgo

- cuando recibe dinero;
- después de una discusión;
- cuando está ansiosa;
- cuando se siente desesperada por las deudas;
- cuando está sola;
- después de una pérdida;
- cuando alguien le presta dinero;
- cuando tiene acceso a determinadas aplicaciones;
- cuando aparece la idea de “recuperar lo perdido”.

Asignación de roles familiares

Rol 1. Coordinador familiar

Una persona responsable de:

- mantener comunicación con el equipo tratante;
- coordinar citas;
- supervisar que se cumplan los acuerdos;
- convocar reuniones familiares breves cuando sea necesario.

Rol 2. Responsable financiero temporal

Una persona encargada de:

- organizar pagos;
- revisar ingresos y gastos;
- evitar entrega de efectivo no planificado;
- administrar temporalmente cuentas destinadas a obligaciones;
- llevar registro de deudas.

Asignación de roles familiares

Rol 3. Acompañamiento

Persona(s) encargadas de:

- acompañarla en períodos de mayor riesgo;
- actividades fuera del entorno de juego;
- evitar aislamiento;
- favorecer rutinas saludables.

Rol 4. Apoyo emocional

Persona que:

- escuche;
- no juzgue;
- no discuta durante una crisis;
- ayude a identificar señales de riesgo;
- recuerde las estrategias acordadas.

Rol 5. Enlace médico

Responsable de:

- acompañar a psiquiatría;
- llevar información sobre síntomas;
- informar cambios relevantes;
- favorecer adherencia al tratamiento.

Lo que la familia **SÍ** debe hacer

- Establecer límites claros.
- Mantener una postura firme y calmada.
- Supervisar temporalmente el acceso al dinero.
- Ayudar a organizar las deudas.
- Acompañar al tratamiento.
- Favorecer rutinas.
- Reconocer avances.
- Informar recaídas al equipo terapéutico.
- Preguntar directamente por el impulso de jugar.
- Celebrar conductas de recuperación, no solamente ausencia de juego.

Lo que la familia NO debe hacer

- No prestarle dinero para jugar.
- No pagar silenciosamente todas sus deudas.
- No encubirla ante acreedores.
- No justificar sus conductas.
- No humillarla.
- No insultarla.
- No amenazarla constantemente.
- No discutir mientras está en una crisis de impulso.
- No darle grandes cantidades de efectivo.
- No pensar que una promesa de “no volveré a jugar” es suficiente.
- No utilizar la vigilancia como sustituto del tratamiento.

Manejo de las deudas

Primero: detener el crecimiento de la deuda.

Después:

1. Identificar todas las deudas.
2. Identificar acreedor.
3. Monto.
4. Intereses.
5. Fecha de pago.
6. Consecuencias de incumplimiento.
7. Préstamos informales.
8. Dinero prestado por familiares.
9. Tarjetas.
10. Instituciones financieras.

Después establecer:

Regla familiar

No adquirir nuevas deudas para pagar deudas generadas por el juego sin un plan financiero estructurado.

Tratamiento psiquiátrico

Evaluación psiquiátrica

Objetivos:

- revisar diagnóstico;
- valorar comorbilidades;
- revisar medicación actual;
- valorar efectos secundarios;
- evaluar síntomas afectivos, ansiosos, impulsividad y sueño;
- valorar riesgo suicida;
- determinar necesidad de ajustes farmacológicos.

Fase 2 — Intervención cognitivo-conductual

- identificación de pensamientos asociados al juego;
- distorsiones cognitivas;
- tolerancia al malestar;
- manejo de impulsos;
- solución de problemas;
- habilidades de afrontamiento.

Fase 3 — Rehabilitación funcional

- recuperación de responsabilidades;
- manejo financiero;
- recuperación de relaciones;
- actividades gratificantes no relacionadas con juego;
- habilidades sociales;
- autonomía.

Fase 4 — Prevención de recaídas

- **identificación de señales tempranas;**
- **plan de emergencia;**
- **exposición gradual a situaciones de riesgo;**
- **fortalecimiento de habilidades;**
- **autonomía financiera progresiva.**

¿Cómo sabemos que está mejorando?

Indicadores de recuperación

- ausencia/reducción sostenida del juego;
- disminución de impulsos;
- no solicitar préstamos;
- transparencia financiera;
- asistencia a tratamiento;
- mejor regulación emocional;
- cumplimiento de rutinas;
- reducción de conductas de ocultamiento;
- recuperación progresiva de responsabilidades;
- reducción de conflictos familiares;
- aumento progresivo de autonomía.

Presentado por Diana Díez

¡Muchas
gracias!

www.unsitiogenial.es